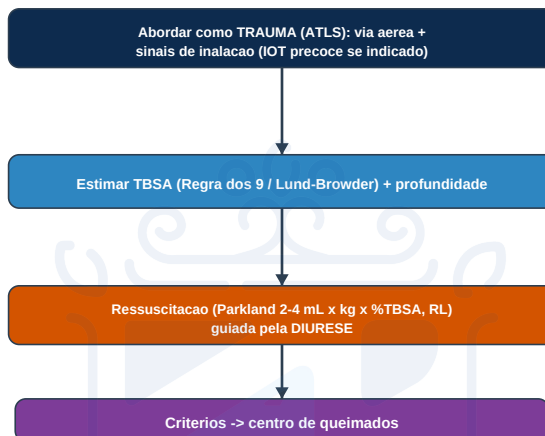


QUEIMADURAS — ABCDE + PARKLAND

FLUXOGRAMA — É TRAUMA

QUEIMADO — ABCDE -> TBSA -> RESSUSCITAÇÃO



AValiação INICIAL (ABCDE) E INALAÇÃO

VIA AÉREA É PRIORIDADE

- A: sinais de lesão por INALAÇÃO (queimadura facial, narinas carbonizadas, fuligem, estridor, rouquidão) -> IOT PRECOCE
- B: O2 suplementar; suspeita de intoxicação por CO -> O2 a 100%
- C: 2 acessos calibrosos (preferir área não queimada); iniciar fluidos se queimadura extensa
- D: nível de consciência e analgesia; E: expor, estimar lesões e cobrir com lençol limpo/aquecido (evitar hipotermia), retirar roupas/joias
- Abordar SEMPRE como trauma (pode haver lesões associadas)

PROFUNDIDADE E TBSA

Item	Descrição
1º grau	Eritema, doloroso, SEM bolhas (não entra no cálculo de TBSA)
2º superficial	Bolhas claras, dor intensa
2º profundo	Menos doloroso, palidez, risco de cicatriz
3º / 4º grau	3º: pele seca, branca/carbonizada, indolor; 4º: atinge músculo/osso
TBSA (Regra dos 9)	Cabeça 9%, cada braço 9%, tronco ant 18%, post 18%, cada perna 18%, genitais 1% (Lund-Browder em crianças)

RESSUSCITAÇÃO VOLÊMICA

Rx PARKLAND GUIADA POR DIURESE

Indicação: adultos $\geq 15-20\%$ TBSA; crianças $\geq 10-15\%$ TBSA (contar 2º grau ou mais profundo)

Fórmula (Parkland modificada): $2-4 \text{ mL} \times \text{kg} \times \% \text{TBSA}$ de RINGER LACTATO nas 24h — METADE nas primeiras 8h (desde a lesão), metade nas 16h seguintes (crianças 3-4 mL)

AJUSTAR pela DIURESE (principal parâmetro): adultos 0,5-1 mL/kg/h; crianças 1 mL/kg/h

Queimadura elétrica/rabdomiólise: alvo de diurese maior (1-2 mL/kg/h) para proteção renal

Evitar 'fluid creep' (hiper-ressuscitação -> edema pulmonar/cerebral, síndrome compartimental)

Analgesia: opioide EV (Morfina 0,1-0,2 mg/kg; Fentanil 1-2 mcg/kg) + adjuvantes

FERIDA, TÉTANO, ATB E INTERNAÇÃO

CONDUTAS

- ☐ Ferida: resfriar com água corrente fria por 10-20 min (NÃO usar gelo); curativo estéril não aderente; bolhas íntegras em geral NÃO abrir no PS
- ☐ Atualizar profilaxia antitetânica conforme histórico (ferida traumática)
- ☐ ATB sistêmico NÃO de rotina — só se sinais de infecção (febre, pus, eritema progressivo, linfangite)
- ☐ Critérios para CENTRO DE QUEIMADOS: TBSA alta (adulto $\geq 20-25\%$, criança $\geq 10-15\%$), 3º grau, face/mãos/pés/genitais, circunferencial de tórax, elétrica/química, inalação
- ☐ Complicações: choque hipovolêmico, edema pulmonar/cerebral (hiper-ressuscitação), infecção/seps, IRA

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos/ ____ kg; queimadura ____ (térmica/elétrica/química); TBSA ____ % ; profundidade ____; inalação: ____.
- Via aérea ____ (IOT?); diurese ____ mL/h; volume RL infundido ____ mL; analgesia ____; antitetânica ____.
- Localizações críticas (face/mãos/pés/genitais/circunferencial): ____.
- Solicito centro de queimados; transporte com via aérea segura, RL guiado por diurese e proteção térmica.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Adulto de 70 kg com 30% de TBSA. Pela fórmula de Parkland (4 mL), qual o volume nas primeiras 24h e como distribuir?

- A) 2.000 mL, tudo nas primeiras 8h
- B) Cerca de 8.400 mL de Ringer Lactato, metade nas primeiras 8h e metade nas 16h seguintes
- C) 1.000 mL em 24h
- D) 8.400 mL, todo no fim das 24h
- E) Não há necessidade de fluidos

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o principal parâmetro para guiar a ressuscitação volêmica no queimado?

- A) Pressão arterial isolada
- B) Diurese horária (0,5-1 mL/kg/h em adultos)
- C) Frequência cardíaca apenas
- D) Temperatura
- E) Peso diário

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual achado indica lesão por inalação e necessidade de intubação precoce?

- A) Eritema isolado em membro
- B) Queimadura facial, narinas carbonizadas, fuligem na orofaringe, estridor/rouquidão
- C) Bolha em 2º grau no braço
- D) Dor controlada
- E) TBSA de 5%

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre o antibiótico sistêmico no queimado, é correto:

- A) Profilaxia para todos desde a admissão
- B) Não é de rotina; usar apenas se sinais de infecção (febre, pus, eritema progressivo)
- C) Sempre carbapenêmico
- D) Apenas tópico nunca sistêmico
- E) Contraindicado em qualquer caso

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual conduta local inicial é adequada na queimadura térmica?

- A) Aplicar gelo diretamente
- B) Resfriar com água corrente fria por 10-20 min e cobrir com curativo estéril não aderente
- C) Furar todas as bolhas no PS
- D) Aplicar pasta de dente
- E) Deixar exposta sem cobertura

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Parkland ($4 \text{ mL} \times 70 \text{ kg} \times 30\%$) = ~8.400 mL de Ringer Lactato nas 24h, com metade nas primeiras 8h (desde a lesão) e metade nas 16h seguintes, ajustado pela diurese.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A diurese horária é o principal parâmetro de ajuste (0,5-1 mL/kg/h em adultos; 1 mL/kg/h em crianças); evita tanto a hipoperfusão quanto a hiper-ressuscitação ('fluid creep').

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Queimadura facial, narinas carbonizadas, fuligem na orofaringe e estridor/rouquidão indicam lesão por inalação e risco de obstrução — justificam intubação precoce.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O ATB sistêmico não é profilático de rotina no queimado; reserva-se aos sinais de infecção (febre, pus, eritema progressivo, linfangite).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Resfria-se com água corrente fria por 10-20 min (NÃO gelo, que agrava a lesão) e cobre-se com curativo estéril não aderente; bolhas íntegras em geral não são abertas no PS.

SM24
Suporte ao Plantão Médico